

Talepunkter til K2-møte

IMA — kort svar på de fem spørsmålene

01 Bakgrunn — hvilket problem løser dere?

Ansatte i omsorgsboliger sitter på verdifull kunnskap om beboerne gjennom pleiedokumentasjonen, men mønstre i uro, utagering og søvn drukner i hundrevis av notater over måneder og skiftende vakter. Ingen enkeltperson har tid eller kapasitet til å se sammenhengene — det er en grense for hva hukommelse og oppmerksomhet rekker over, ikke et kritikkpunkt mot personalet.

02 Forretningsidéen — hva gjør konseptet unikt?

IMA kombinerer en regelbasert mønster- og hypotesemotor med faglig vurdering fra psykolog og helsefagarbeider i samme leveranse. Det teknisk unike er at motoren bruker SBERT til semantisk analyse — den forstår meningen i et notat uavhengig av hvem som har skrevet det og hvordan den enkelte ansatte har formulert seg. To ansatte kan beskrive samme hendelse med helt ulike ord, og motoren kjenner likevel igjen at det er samme mønster. Det fanger sammenhenger på tvers av vakter og skrivestiler som manuell lesing eller enkelt tekstsøk aldri ville avdekket.

03 Team — kompetanse og erfaring

Christian Garmann Schjelderup (grunnlegger): 16 år som helsefagarbeider i omsorgsbolig, videreutdanning i anvendt maskinlæring og cloud security, bachelor i cybersikkerhet (pågående). Har bygget hele plattformen selv. Øivind Stålesen (psykolog): 7 år klinisk erfaring i spesialisthelsetjenesten og bedriftshelsetjeneste, spesialisering i organisasjonspsykologi, tar det kliniske ansvaret for konklusjonene.

04 Status og ambisjoner — potensial

Plattformen kjører i dag på syntetiske testdata, ikke skarpe pasientdata. Vi har ikke bare beskrevet sikkerhet og personvern — vi har bygget og testet det i praksis: 150 av 151 automatiske tester består, blant annet ekte kryptering av dataene og en innebygd sperre som hindrer at systemet kan brukes på ekte pasientdata før alt er godkjent. Neste steg er en pilot med reelle data når personvernrammene er på plass. Markedet er ca. 2 270 boligbaser og bofellesskap i Norge (SSB), og vi starter med boliger for utviklingshemmede, rus og psykiatri — under 4 % markedsandel er nok til å bære driften.

05 Behov — hva trenger dere fra K2?

Viktigst: juridisk hjelp med GDPR — behandlingsgrunnlag, databehandleravtale og DPIA må på plass før journaldata kan deles. Deretter søknadshjelp til vekstmidler for å komme fra ferdig plattform til gjennomført pilot, og forretningsmodellering — prismodell og hvordan tjenesten selges inn i en kommunal innkjøpsprosess.